# 生物同源荷尔蒙替代疗法（BHRT）处方草案

**【草案——须经执业医师审核签字后方可生效】**

## 一、客户信息

编号：SYN-DEMO-01　性别：女　年龄：53　BMI：22.7　血压：122/78

分期：☐围绝经期　☑绝经早期(<10年)　☐绝经晚期(≥10年/≥60岁)　☐手术绝经/POI　☐男性性腺功能减退

获益/风险最有利窗口；乳膏或 Pellet

## 二、安全闸门结果

结论：☑可进行　☐暂缓　☐禁忌

## 三、主要症状与评分

MRS 总分：18（重度）　躯体 9 / 心理 7 / 泌尿生殖 2
主要诉求：睡眠差、潮热

## 四、给药途径选择及理由

☑经皮乳膏　☐Pellet 皮下植入

- 乳膏优先：可当日停用、便于滴定

## 五、处方明细

| 药品 | 规格 | 剂量 | 有效成分 | 用法 / 部位 | 频次 | 疗程 / 数量 | 目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-Est 双雌乳膏 0.5% (E3:E2 = 80:20) | 0.5% | 1 转 | Bi-Est 1.25 mg（E2 0.25 mg） | 前臂内侧 / 大腿内侧，轮换部位 | 每日早晨 1 次 | Topi-Click 30 g × 1（约 90 天用量） | 血管舒缩症状 / 雌激素缺乏 |
| 口服微粒化黄体酮胶囊 100 mg | 100 mg | 1 粒 | 100 mg | 口服 | 每晚睡前，连续 | 90 粒 | 子宫内膜保护+ 睡眠 |

子宫内膜保护方案：口服微粒化黄体酮 100 mg 每晚连续

## 六、使用说明（客户版）

- 涂抹乳膏前后洗手；部位轮换；涂抹处数小时内避免与儿童、宠物皮肤接触

- 每日记录症状日记（潮热次数、睡眠、情绪、出血）
- 请勿自行加量或停药，调整需经医生评估
- 出现以下情况立即联系医生：任何阴道出血、单侧腿肿痛、胸痛气短、剧烈头痛或视物异常、乳房新发肿块、声音变粗

## 七、复诊与检测计划

| | | |
|---|---|---|
| 2026-11-10 | 开始治疗 | 基线检测与影像已存档 |
| 2026-11-24 | 2 周电话随访 | 耐受性；有无阴道出血 |
| 2026-12-29 | 6–8 周 | MRS 复评；症状持续则查 E2 后再滴定（每次 ±1 转） |
| 2027-02-08 | 3 个月 | 复评并稳定剂量 |
| 2027-05-11 | 6 个月 | 性激素、血常规、血压、体重；TVUS（如使用乳膏黄体酮或肌瘤） |
| 2027-11-10 | 每年 | 乳腺影像；TVUS（按需）；血脂；血常规 |

## 八、预期变化（仅供参考）

- 睡眠：一般 1–2 周 起（记录：睡眠日记）
- 潮热：一般 2–4 周 起（记录：频率/严重度记录、MRS）
- 情绪：一般 4–8 周 起（记录：MRS 心理子量表）
- 骨骼：一般 12 个月以上 起（记录：DEXA）

注：个体反应差异显著，以上时间为一般观察，不构成疗效承诺。

## 九、医师审核

审核意见 / 修改：

---

---

执业医师签名：_____　执业证号：_____　日期：_____

## 临床备注（内部）

**假设：**

- 部分检测未填写采样日期，已假设在有效期内
- 乳膏 1 转 = 250 mg（Topi-Click 30 g ≈120 转），使用前需按分装器核实

**建议补充检查：** 硫酸脱氢表雄酮 (DHEA-S)、游离甲状腺素 (FT4)、空腹血糖 (GLU)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、25-羟维生素D、铁蛋白、维生素B12

引擎版本 bhrt-0.1.0　生成日期 2026-11-10